



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN I
KOMITE PPRA
BULAN JANUARI - MARET
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan I Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini:

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	Januar – Maret	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	33	33	0	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM:

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.	S1	Sp 1 pediatrik	Pelatihan PPRA eksternal	Belum terlaksana
Sekretaris	apt. Rifdah Bunga K S.Farm.	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
Anggota	dr. Ari Putriani, Sp.PK	S1	Dokter Patologi Klinik	Pelatihan PPRA eksternal	Terlaksana
	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Ardhi Bustami, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana
	dr. Antonius Setiadi, Sp. B	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Iwan Donosepoetr o, Sp. B.FINACS	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Heriyatmo, Sp.Pd	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Ira Setya, Sp. JP	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Dewi Maharani, Sp. S	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Titok, Sp. M	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Aida M., Sp. OG	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Andy, Sp. P	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Pradana Nurhadi, Sp. U	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Arianto, Sp. OT	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Nimim , Sp. KK	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Dwi Nurwulan Pravita., Sp. KK	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

	dr. Rino R.	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Yuanita Eka L, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Pipin Purwa Ningrum, S. Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Ajeng Janani, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Guspa Gayatri A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Fadilah Maulana Ihram A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Diryanti Barin Putri, S. Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep	S1/D3	Bidan	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Sherly Rosita, Amd. Kep.	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Lusianah Nurul Islamiyah, Amd. Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Nabila Rizky Amalia, Str. Kes	S1/D3	Laboratorium	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana

	Nuril Maulidatul Qorida, S.KM	S1/D3	Mutu	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana
--	-------------------------------------	-------	------	--	---------------------

III. PROGRAM KERJA DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Pembuatan Panduan Penggunaan Antibiotika RS	Terdapat pembaharuan Panduan Penggunaan Antibiotik (PPAB) tahun 2026	Pedoman penggunaan antibiotik yang ada masih relevan untuk di gunakan
2	Sosialisasi PPRA	Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA tahun 2026	
3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Antibiotika	Rapat untuk membahas tentang pengumpulan data penggunaan antibiotika di RS Prima Husada	Laporan triwulan

IV. FASILITAS

No	Kegiatan Pokok	Ket.
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen, belum ada realisasi

V. INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA

No	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	≥50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2026	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

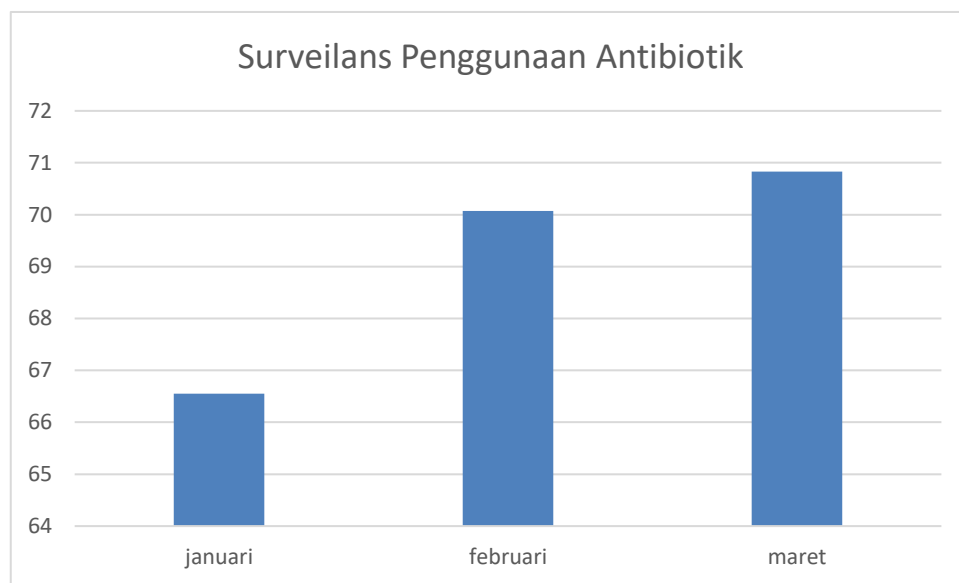
VI. PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN I

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada

a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

No	Bulan	Prosentase (%)
1	Januari	66,55
2	Februari	70,07
3	Maret	70,83

b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada



c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

- Pengambilan data diambil dari SIMRS
- Penggunaan antibiotik tertinggi pada bulan Maret sebesar 70,83 %, pada bulan Februari sebesar 70,07 %, dan pada bulan Januari sebesar 66,55 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik lebih dari target (>50%).

d. Rencana tindak lanjut

- Dilakukan sosialisasi masiv terkait penggunaan antibiotik bijak dan rasional terhadap DPJP.
- Dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi terkait penggunaan antibiotik.

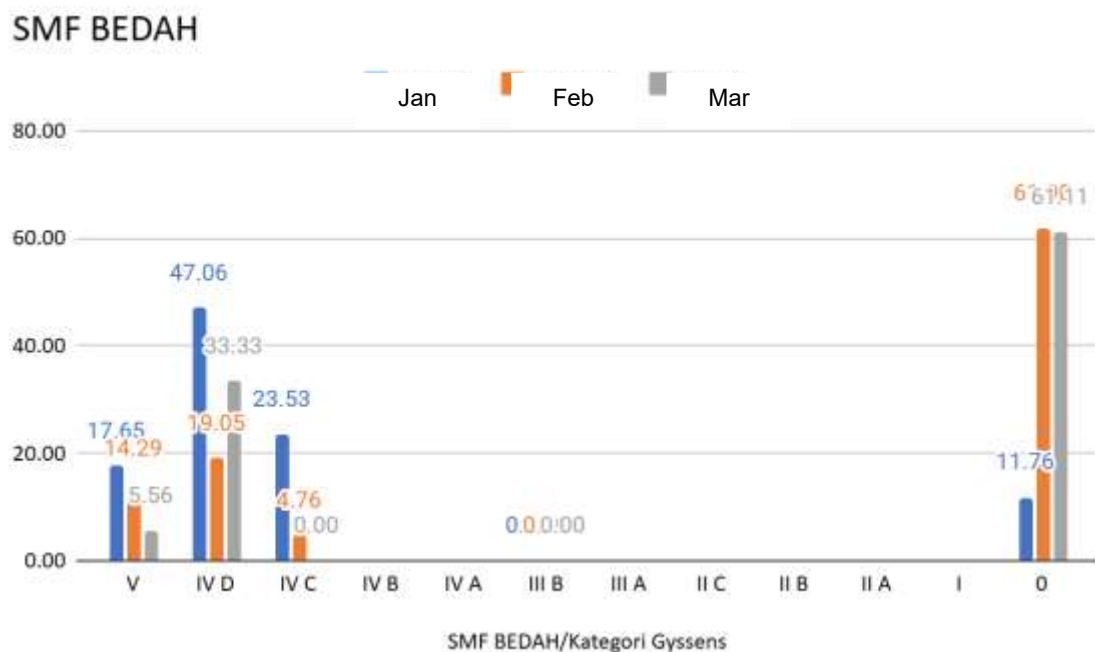
2. Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

a. SMF Bedah

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	17.65	14.29	5.56
2.	Kategori IV D	47.06	19.05	33.33
3.	Kategori IV C	23.53	4.76	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	5	5
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	11.76	61.90	61.11
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 1. Pada triwulan I, terdapat kategori 0 pada bulan Februari dan Maret yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Februari sebesar 61.90%.
 2. Kategori IV C terdapat pada SMF Bedah sebesar 23.53% dibulan Januari yang

menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.

3. Kategori IV D terdapat pada SMF Bedah sebesar 47.06% dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 4. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 17.65% dibulan Januari yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut
 - Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) sudah memenuhi standar pada bulan Februari dan Maret. Namun untuk kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

b. SMF Obgyn

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	5.26	17.65	10.53
2.	Kategori IV D	0	5.88	0
3.	Kategori IV C	0	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	19	16	26
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	5.2	0	5.26
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	89.47	76.47	84.21
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

SMF OBGYN



- Analisa penggunaan antibiotik secara kualitatif (Gyssens)

- Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertingginya 89.47% pada bulan Februari. Hasil tersebut memenuhi standart yaitu perolehan persentase kategori 0 $\geq$ 50%.
- Kategori II A, ada pada bulan Maret dengan prosentase terbesar yaitu 5.26% yang

-
- menunjukkan dosis pemberian antibiotik tidak tepat.
3. Kategori IV D terdapat pada SMF Obgyn sebesar 5.88% dibulan februari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 4. Kategori V terdapat pada SMF Obgyn dengan nilai terbesar pada bulan Februari sebsar 17.65% yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan I seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori II A yaitu dosis antibiotik yang tidak tepat, IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya dan kategori V yaitu pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

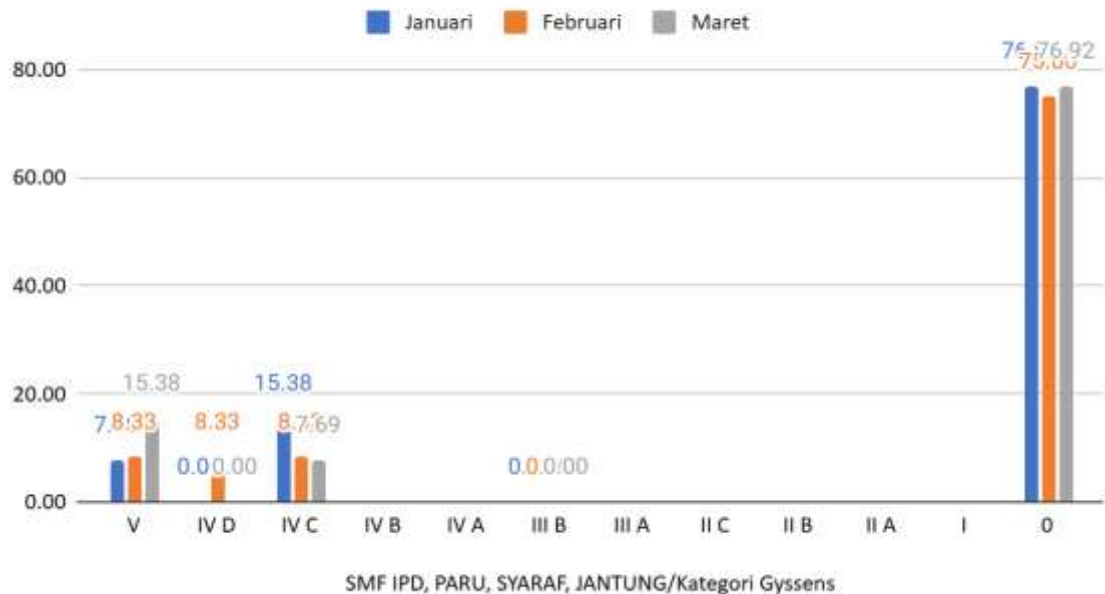
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	7.69	8.33	15.38
2.	Kategori IV D	0	8.33	0
3.	Kategori IV C	15.38	8.33	7.69
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	9	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	76.92	75	76.92
Total		100	100	100

- Grafik audit antibiotik SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

SMF IPD, PARU, SYARAF, JANTUNG



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 - Pada triwulan I, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Januari dan Maret sebesar 76.92%. Pada triwulan I ini, ketiga bulan telah memenuhi standar yaitu kategori 0 >

50%

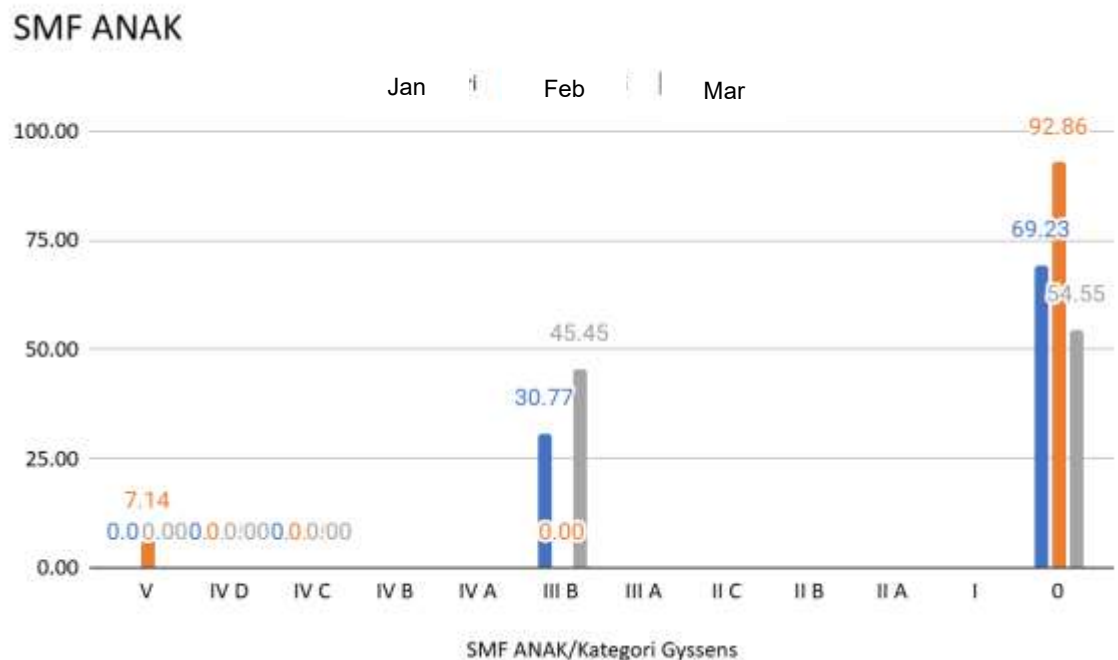
2. Kategori IV C paling tinggi terdapat prosentase sebesar 15.38% dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 3. Kategori IV D, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, kategori IV D terdapat pada bulan Februari dengan prosentase yaitu 8.33%.
 4. Kategori V terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung dengan nilai terbesar pada bulan Maret sebesar 15.38% yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut
Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) sudah mencapai standar di setiap bulannya. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain, yaitu IV C, IV D dan V. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya.

d. SMF Anak

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	0	7.14	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	8	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	30.77	0	45.45
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	69.23	92.86	54.55
Total		100	100	100

- Grafik audit antibiotik SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 - Pada triwulan I, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Februari sebesar 92.86%.
 - Kategori III B, dengan prosentase sebesar 45.45% terbesar dibulan Maret yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.

-
- Kategori V terdapat prosentase 7.14% dibulan Februari yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
 - Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Anak, terdapat persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) dengan prosentase tertinggi 92.86%. Terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukan dengan adanya kategori lain, yaitu III B dan V. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk triwulan berikutnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepsian antibiotik rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: • Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA.	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: 1. melakukan sosialisasi secara rutin dan terus menerus

3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2026

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2026 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.

4. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan I Tahun 2026

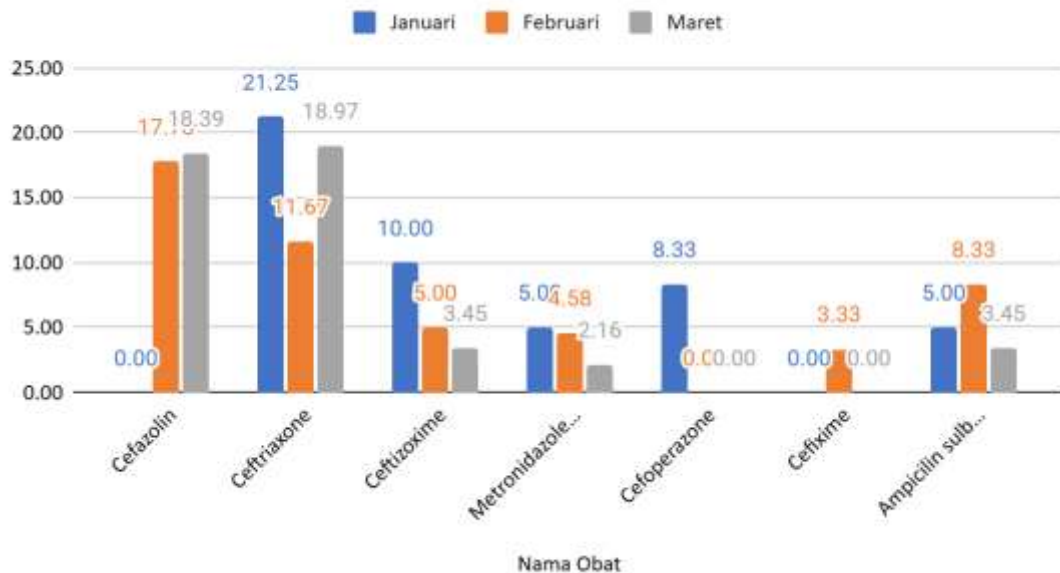
a. SMF Bedah

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Cefazolin	0.00	17.78	18.39
2.	Ceftriaxone	21.25	11.67	18.97
3.	Ceftizoxime	10.00	5.00	3.45
4.	Metronidazole tab	5.00	4.58	2.16
5.	Cefoperazone	8.33	0.00	0.00
6.	Cefixime	0.00	3.33	0.00
7.	Ampicillin Sulbactam	5.00	8.33	3.45

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF BEDAH



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF bedah

Penggunaan antibiotik pada triwulan I tahun 2026 oleh SMF Bedah terdiri dari Cefazolin, Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole tab, Cefoprazone, Cefixime dan Ampicilin Sulbactam. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Januari sebesar 21,25 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

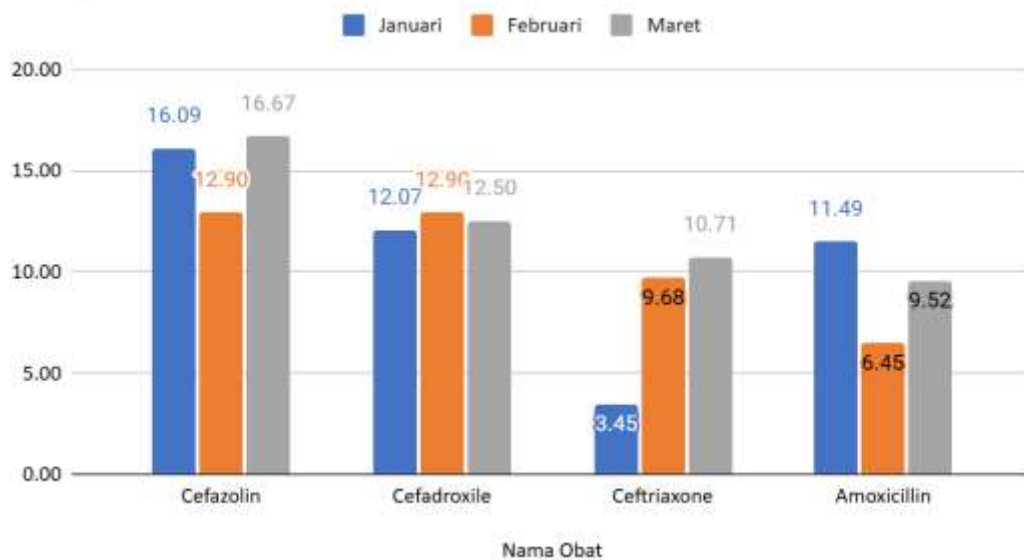
b. SMF Obgyn

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF obgyn secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Cefazolin	16.09	12.90	16.67
2.	Cefadroxile	12.07	12.90	12.50
3.	Ceftriaxone	3.45	9.68	10.71
4.	Amoxicillin	11.49	6.45	9.52

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF obgyn

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF obgyn

Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin, Cefadroxile, Ceftriaxone dan Amoxicillin. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefazoline. Nilai DDD/100 Cefazoline tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 16,67 DDD/100 hari rawat inap.

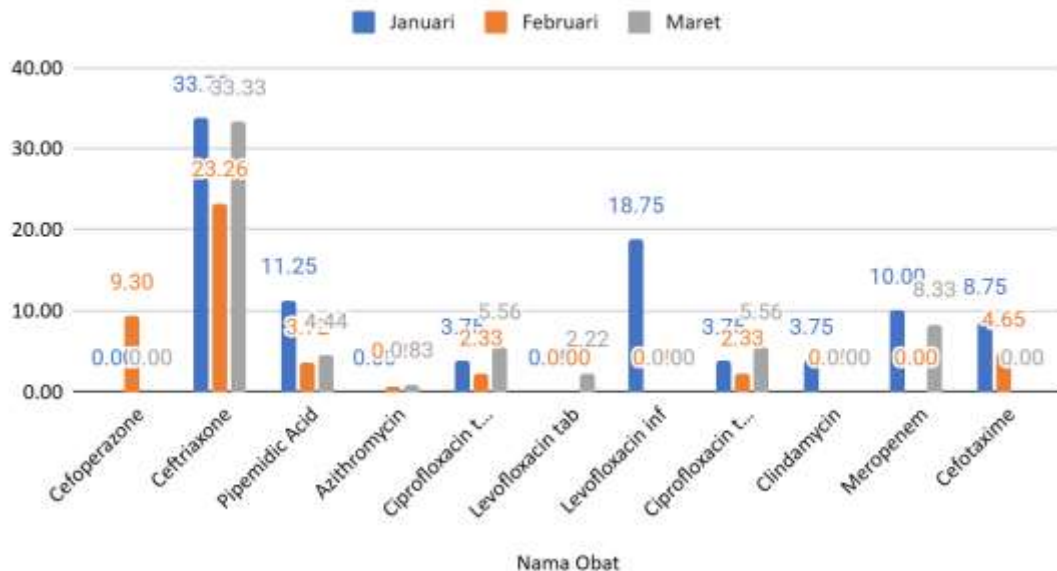
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Cefoperazone	0.00	9.30	0.00
2.	Ceftriaxone	33.75	23.26	33.33
3.	Pipemidic Acid	11.25	3.72	4.44
4.	Azithromycin	0.00	0.70	0.83
5.	Ciprofloxacin tab	3.75	2.33	5.56
6.	Levofloxacin tab	0.00	0.00	2.22
7.	Levofloxacin inf	18.75	0.00	0.00
8.	Ciprofloxacin tab	3.75	2.33	5.56
9.	Clindamycin	3.75	0.00	0.00
10.	Meropenem	10.00	0.00	8.33
11.	Cefotaxime	8.75	4.65	0.00

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD, PARU, SYARAF, JANTUNG



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan I tahun 2026 terdiri dari 11 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxone terdapat dibulan Januari dengan nilai 33,75 DDD/100 hari rawat inap.

VII. KESIMPULAN

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada pada triwulan I tahun 2026 paling banyak terjadi pada bulan Maret yakni sebesar 70,83%.
2. Penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang belum memenuhi target pada setiap bulan dalam pelaporan triwulan 1 hanya pada SMF Bedah yaitu bulan Januari. Sementara pada SMF Obgyn, Anak, IPD, Jantung, Paru dan Syaraf sudah memenuhi standar di setiap bulannya.
3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik 2026 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.
4. Penggunaan antibiotik terbanyak oleh SMF Bedah dan SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf pada triwulan I tahun 2026 adalah antibiotik Ceftriaxone sebesar 62,50 dan 38,16 DDD/100 hari rawat inap. Pada SMF Obgyn antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Cefazoline dengan nilai 16,67 DDD/100 hari rawat inap
- 5.

Malang, 04 April 2026

Penyusun,

Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes